Приложение № ___
к Приказу Министра
здравоохранения
Республики Узбекистан
№____ от «____» _____2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ “БРАДИАРИТМИИ”

ТАШКЕНТ – 2025

"УТВЕРЖДАЮ"
Министр здравоохранения
Республики Узбекистан
А.А. Худаяров
_____
«____»_____2025 г .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ “БРАДИАРИТМИИ”

ТАШКЕНТ – 2025

"СОГЛАСОВАНО"
Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Х.Г. Фозилов

_____

_____ _____ 2025 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ “БРАДИАРИТМИИ”

ТАШКЕНТ – 2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИЯМ

БРАДИАРИТМИИ

Кодирование по МКБ-10:	Нозологическое название:	Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
I44	Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада левой ножки пучка [Гиса].	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I44.0	Предсердно-желудочковая блокада первой степени.	Кардиолог ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I44.1	Предсердно-желудочковая блокада второй степени.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I44.2	Предсердно-желудочковая блокада полная.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог /

					Невропатолог / Нефролог
I44.3	Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I44.4	Блокада передней ветви левой ножки пучка.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I44.5	Блокада задней ветви левой ножки пучка.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I44.6	Другие и неуточненные блокады пучка.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I44.7	Блокада левой ножки пучка неуточненная.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

I45	Другие нарушения проводимости.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I45.0	Блокада правой ножки пучка.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I45.1	Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I45.2	Двухпучковая блокада.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I45.3	Трехпучковая блокада.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

I45.4	Неспецифическая внутрижелудочковая блокада.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I45.5	Другая уточненная блокада сердца.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I45.8	Другие уточненные нарушения проводимости.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I45.9	Нарушение проводимости неуточненное.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I46	Остановка сердца.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

I46.0	Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I46.1	Внезапная сердечная смерть.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I46.9	Остановка сердца неуточненная.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I49.5	Синдром слабости синусового узла.	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

Кодирование по МКБ-11:	**Нозологическое название:**	**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях**		**Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения**	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены

BC63.5	Нарушение внутрижелудочкового проведение, неуточнённое	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC80.21	Синоатриальная блокада	Кардиолог ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.Z	Нарушение проводимости, неуточнённое	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.Z	Полная предсердно-желудочковая блокада	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
LA8Y	Врождённая блокада сердца	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

BC63.2Z	Полная предсердно-желудочковая блокада при болезни, классифицированных в других рубриках	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.Y	Двухпучковая блокада	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.20	Врождённая полная предсердно-желудочковая блокада	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.21	Приобретенная полная предсердно-желудочковая блокада	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.0	Предсердно-желудочковая блокада, первая степени	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

BC63.1Z	Предсердно-желудочковая блокада, вторая степень неуточнённая	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.5&XK2J	Полная блокада левой ножки пучка Гиса	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.4Z	Блокада левой ножки пучка Гиса, неуточнённая	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.3	Блокада правой ножки пучка Гиса	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.10	Предсердно-желудочковая блокада второй степени высоких градаций	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

BC63.5&XK06	Другая уточнённая блокада ножек пучка Гиса	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.1Y	Bo‘lmacha-qorincha qamali, ikkinchi darajasi	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.3&XK2J	Полная блокада правой ножки пучка Гиса	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.4Z&XK06	Неполная блокада левой ножки пучка Гиса	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.3&XK06	Неполная блокада правой ножки пучка Гиса	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

BC63.41	Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC63.40	Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
BC80.20	Синдром слабости синусового узла	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

***при заполнении стандарта необходимо указать нозологию, ее течение у взрослых, беременных, детей и пожилых людей, а также характер периода заболевания по нозологии.**

Также не рекомендуется заполнять таблицы, не соответствующие нозологии. (Например, если по нозологии не ведется хирургическая практика, таблица (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ) не заполняется, или если нозология не включает паллиативное лечение - не заполняется таблица (ПАЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ).

ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПЕНСАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТДЕЛЕННОЙ НОЗОЛОГИИ БРАДИАРИТМИИ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
		СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Консультация основного специалиста (врача)	1. Семейный врач	+	+				По крайней мере, в период медицинского осмотра 2 раза; 1 раз при наличии заявления по болезни и при наличии указания	Амбулаторное наблюдение продолжается на протяжении всей жизни; Стационарное лечение: 5-10 дней*
	2. Кардиолог		+	+	+	+		
	3. Интервенционный кардиолог (аритмолог)				+	+		
Примечание:								
Консультация специалиста (врача) (дополнительно)	1. Реаниматолог			+	+	+	- Проводит 1 обследование в случае заявления по заболеванию и полное обследование в случае показания.	
	2. Интервенционный кардиолог				+	+		
	3. Кардиохирург					+		
	4. Эндокринолог	+	+	+	+	+		
	5. Невропатолог	+	+	+	+	+		
	6. Нефролог	+	+	+	+	+		
Примечание: (согласно инструкции)								
Основные лабораторные анализы	1. Общий (клинический) анализ крови.	+	+	+	+	+	– 1 раз в случае заболевания и/или по инструкции. – Назначается 2 раза в 1 год (ОАК, Биохимия, липидный спектр, ОАМ)	
	2. Общий (клинический) анализ мочи.	+	+	+	+	+		
	3. АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, мочевина)	+	+	+	+	+		
	4. Маркеры воспалительного ответа (С-реактивный белок, АСЛО, РФ)		+	+	+	+		

	5. Коагулограмма		+	+	+	+	Не менее 1 раза в период стационарного лечения заболевания и/или по инструкции.	
	6. ТТГ			+	+	+		
	7. Электролиты			+	+	+		
Примечание: Количество лабораторных исследований в стационарных условиях определяется исходя из клинического состояния.								
Дополнительные лабораторные исследования	1. **Уровень сахара в крови**	+	+	+	+	+	– 1 раз в случае заболевания и/или по инструкции. – Назначается 2 раза в 1 год (ОАК, Биохимия, липидный спектр, ОАМ) Не менее 1 раза в период стационарного лечения заболевания и/или по инструкции.	
	2. **Высокочувствительные тропонины.**		+	+	+	+		
	3. **МВ-КФК**			+	+	+		
	4. Липидный спектр		+	+	+	+		
	5. Мозговой натрийуретический пептид.			+	+	+		
	6. Д-димер			+	+	+		
	7. Общий белок		+	+	+	+		
	8. Оценка кислотно-щелочного баланса.			+	+	+		
	9. Концентрация анти Ха фактора в крови.					+		
	10. Гепатит В, С			+	+	+		
	11. ВИЧ			+	+	+		
	12. RW			+	+	+		
	13. Группа крови			+	+	+		
Примечание: **если на материально-технической базе СВП/СП имеется возможность обследования КФК с полным липидным спектром, данные обследования должен проводить семейный врач.** Лабораторные исследования обязательно проводит лечащий врач, результаты этих анализов направляются узким специалистам следующего уровня. Повторное лабораторное обследование проводится только по назначению специалиста или в процессе стационарного лечения. Гепатит В,С, ВИЧ, RW и группа крови должны проверяться у пациентов, у которых планируется хуриргическое вмешательство.								
Основные инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	+	+	+	- 1 раз при обращении по болезни и/или по инструкции - Планово 2 раза в 1 год (ЭКГ, ЭхоКГ,	
	2. Трансторакальный ЭхоКГ		+	+	+	+		
	3. Рентгенография грудной клетки		+	+	+	+		
	4. Холтеровское мониторирование ЭКГ (24-		+	+	+	+		

	72 часа)						рентгенография грудной клетки, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ) **- не менее 1 раза в период стационарного лечения по поводу заболевания и/или согласно инструкции.**	
	5. Электрофизиологическое исследование при необходимости (инвазивное, неинвазивное)				+	+		
Примечание:								
	1. Коронарография*				+	+		
	2. МСКТ-обследование сердца			+	+	+		
	3. МРТ сердца					+		
	4. Чреспищеводная ЭХОКГ				+	+		

Примечание: Инструментальные диагностические исследования проводит лечащий врач.
При наличии показаний к лечению в медицинском учреждении другого уровня оно будет направлено вместе с копиями обследования.
Повторное инструментальное диагностическое обследование проводится только по назначению специалиста или в процессе стационарного лечения.
При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинских учреждений.
*при наличии специалиста и оборудования можно проводить данную процедуру.

***ИНСТРУКЦИИ ПО СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: (здесь написаны инструкции по стационарному лечению, которые появляются при амбулаторном лечении)**

Показания к плановому стационарному лечению (без операции):

1. Дневной стационар не распространяется на кардиологических пациентов. Если у пациентов подтверждена симптомная брадиаритмия, их следует госпитализировать.
2. Показания для госпитализации в кардиологическое или терапевтическое отделение клинической больницы и/или районного медицинского объединения и/или частной клиники: - неуточненная брадиаритмия.
3. Показания для направления в клиники областных филиалов Республиканского специализированного научной -практического медицинского центра кардиологии: - симптомная брадиаритмия, нуждающаяся в имплантации кардиостимулирующих устройств.
4. Показания для направления в клиники Республиканского специализированного научной -практического медицинского центра кардиологии или кардиологическое отделение клиник вузов: симптомная брадиаритмия, нуждающаяся в имплантации кардиостимулирующих устройств.

Инструкция по неотложному стационарному лечению (хирургической практике):

1. Хирургические вмешательства в условиях районных медицинских объединений не проводятся.
2. Показания к обращению в региональное отделение скорой медицинской помощи и/или реанимации областного многопрофильного центра и/или областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии: - гемодинамически нестабильные симптомные брадиаритмии, острая сердечная недостаточность, стенокардия, нарушения мозгового кровообращения.
3. Направление в Республиканский специализированный научно -практический медицинский центр кардиологии или отделение кардиохирургии или хирургической аритмологии клиник высших учебных заведений: - симптомные брадиаритмии Осложнения заболевания: - острая/хроническая сердечная недостаточность; - внезапная сердечная смерть; - тромбоэмболические осложнения

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка				
		СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
	1. Почечный клиренс по Кокрофту			+	+	+	У пациентов находящихся на антикоагулянтной терапии	

Примечание: необходимо оценить ЭКГ и ЭхоКГ а также наличие симптомов, в зависимости от результатов рассмотреть имплантацию устройств (одно/двухкамерный кардиостимулятор).

(МЕДИКАМЕНТОЗОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное лечение)		По уровню и виду ПЛАНОВОЙ медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка				
Название препарата (не патентовано международное).	Дозировка и способ применения препарата	ОШП/ОП	КТМП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
1. М-холиноблокаторы: Атропин сульфат	0,5-1 мг в/в.	+	+	+	+	+	при необходимости через 10 мин введение можно повторить	-
2. Адреномиметики: Эпинефрин, Фенилэфрин	При асистолии: внутрисердечно 0,5 мг (разбавляют 10	+	+	+	+	+	1 раз, при неэффективности повторить пробу	-

	мл 0,9% раствора натрия хлорида или другим раствором); во время реанимационных мероприятий — по 0,5–1 мг (в разбавленном виде) внутривенно каждые 3–5 минут. через 5-10 минут						**через 5-10 минут**	
Примечание. Все препараты вызывающие брадиаритмию должны быть исключены из терапии. Лечебные мероприятия (дополнительное лечение) при наличии основного заболевания (ИБС, АГ, СД, ХСН) необходимо применять лекарственные средства по стандартам основного заболевания.								

(МЕДИКАМЕНТОЗОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное лечение)		**По уровню и виду ЭКСТРЕННОЙ медицинской помощи**					**Средняя суточная дозировка**	**Дозировка на один курс**
		Амбулаторное лечение		**Стационарная поддержка**				
Название препарата (не патентовано международное).	**Дозировка и способ применения препарата**	**ОШП/ОП**	**КТМП**	**Районные (городские) больницы**	**Медицинские учреждения областного уровня**	**Медицинские учреждения республиканского уровня**		
1. М-холиноблокаторы: Атропин сульфат	**0,5-1 мг в/в.**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**при необходимости через 10 мин введение можно повторить**	**-**
2. Адреномиметики: Эпинефрин, Фенилэфрин	**При асистолии: внутрисердечно 0,5 мг (разбавляют 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида или другим раствором); во время**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**1 раз, при неэффективности повторить пробу через 5-10 минут**	**-**

	реанимационных мероприятий — по 0,5–1 мг (в разбавленном виде) внутривенно каждые 3–5 минут. через 5-10 минут							

Примечание. Все препараты вызывающие брадиаритмию должны быть исключены из терапии.

Лечебные мероприятия (дополнительное лечение) при наличии основного заболевания (ИБС, АГ, СД, ХСН) необходимо применять лекарственные средства по стандартам основного заболевания.

Лечебные мероприятия (дополнительное лечение)		**По уровню и виду ЭКСТРЕННОЙ медицинской помощи**					**Средняя суточная дозировка**	**Дозировка на один курс**
		Амбулаторное лечение		**Стационарная поддержка**				
препарата (международно не запатентовано).	**Дозировка и способ применения препарата**	**СВП/СП**	**МПЦП**	**Районные (городские) больницы**	**Медицинские учреждения областного уровня**	**Медицинские учреждения республиканского уровня**		
Допаминстимуляторы **- Допамин**	**в/в 5-20 мкг/кг/мин**			**+**	**+**	**+**	**Начало с 5 мкг/кг/мин и увеличение на 5 мкг/кг/мин каждые 2 мин.**	
Примечание.								

ПЛАНОВАЯ/ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	**По уровню и виду плановой медицинской помощи**				
	Амбулаторное лечение		**Стационарная поддержка**		
Название операции/вмешательства/лечения	**СВП/СП**	**МПЦП**	**Районные (городские) больницы**	**Медицинские учреждения областного уровня**	**Медицинские учреждения республиканского уровня**
1. Установка кардиостимулятора (временный, постоянный)				**+**	**+**
2. Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий				**+**	**+**
3. Аорто-коронарное шунтирование				**+**	**+**
Комментарий: ЧКВ: если в коронарном бассейне имеется 1 или 2 поражения сосудов (оценка SYNTAX ниже 32 баллов) и оптимальная медикаментозная					

терапия недостаточно эффективна. **АКШ: при 3-х и многососудистом поражении коронарного бассейна (балл SYNTAX выше 32 баллов), либо при поражении левой коронарной артерии, либо при наличии СД.**

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка		
Диетическая таблица и ее продолжительность	СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
Стол №10 – на всю жизнь Соответственно определяют этиологию предсердных тахиаритмий.	+	+	+	+	+

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансерная деятельность	Название медицинских услуг	ОШП/ОП	КТМП	Минимальное количество событий	Период диспансерного контроля
Консультация эксперта (врача)	1. Медсестра	+	+	Планово 2 раза в 1 год	
	2. Семейный врач	+	+		
	3. Кардиолог		+		
	4. Невролог		+		
	5. Эндокринолог		+		
Лабораторные испытания	1. Общий анализ крови	+	+	Планово 2 раза в 1 год	
	2. Общий анализ мочи	+	+		
	3. Содержание сахара в крови	+	+		
	4. Креатинин в крови	+	+		
	5. АЛТ, АСТ, билирубин	+	+		
	6. Коагулограмма	+	+		
Примечание. При периодических обследованиях согласно инструкции рекомендуются дополнительные лабораторные исследования. * Эти специалисты будут осмотрены регионом/МИАТМ по рекомендации кардиолога. **Реализуется исходя из материально-технических возможностей учреждения.					
Инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	Планово 2 раза в 1 год	
	2. ЭХОКГ		+		
	3. ХМЭКГ		+		

	4. Рентген грудной клетки		**+**		
Примечание. После имплантации постоянного кардиостимулятора необходимо проверять функцию кардиостимулятора 2 раза в год в зеведение где было проведено имплантация данного устройства. Во время периодических осмотров рекомендуется проводить дополнительные инструментальные проверки. * для проведения данных исследований пациент регулярно направляется в региональные/НПМЦ/многопрофильные центры по рекомендации кардиолога.					